



СМ-Клиника
многопрофильный медицинский холдинг



Общество с ограниченной

ООО "СМ-Медика" с ограниченной

Адрес: 117418, Москва, г. Новочеремушкинская ул., дом № 65, корпус 1

Телефон: +7 (495) 777-48-49

Факс: ИНН 7709244970

Адрес: 117418, г. Москва

Е-mail: ул. Новочеремушкинская, д.65, корп.1

Лицензия № ЛО41-01137-77/00351219

Амбулаторная карта № АМ6217403

Прием врача

Дата приема: 06.12.2025 Время: 19:27

ФИО пациента: Микова Чиана Сергеевна

Дата рождения: 24.01.1977 Возраст на момент осмотра: 48 ИДС получено.

Врач: Байборodin Александр Борисович

Описание

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ

С УЗКОСПЕКТРАЛЬНЫМ NBI ИССЛЕДОВАНИЕМ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ОБОРУДОВАНИЕ: Эндоскопическая система Olympus EVIS EXERA III - SV 190 Видеогастроскоп Olympus GIF N185, №1. Моечная машина BANDEQ CYW 501.

АНЕСТЕЗИЯ/ СЕДАЦИЯ: пропофол

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:

ГОРТАНОГЛОТКА: Аппарат введен в гортаноглотку, слизистая оболочка гортаноглотки бледно-розовая, черпалонадгортанные складки симметричные, голосовые связки без особенностей. Грушевидные синусы СВОБОДНЫЕ.

ПИЩЕВОД: Устье свободно проходимо эндоскопом. Просвет не изменен, стенки эластичные, хорошо расправляются при подаче воздуха. Перистальтика равномерная на всем протяжении. В просвете по стенкам во всех отделах ОТСУТСТВУЕТ содержимое. Слизистая пищевода РОЗОВАЯ на протяжении.

Пищеводно-желудочный переход имеет НОРМАЛЬНЫЙ рисунок продольных палисадных сосудов. Граница между пищеводным и желудочным эпителием (Z-линия) в виде растянутого округлого зубчатого кольца, располагается на расстоянии 39 см от зубного ряда на 1 см выше уровня пищеводного отверстия диафрагмы

КАРДИЯ в покое смыкается не полностью, при осмотре в инверсии отмечается неПЛОТНОЕ замыкание кардии вокруг эндоскопа.

ЖЕЛУДОК обычной формы и размеров. В желудке умеренное количество слизи без примеси ЖЕЛЧИ. Содержимое частично аспирировано. СКЛАДКИ большой кривизны расположены продольно, извитые, рельефные, хорошо расправляются при подаче воздуха. Перистальтика равномерная. Угол желудка хорошо выражен. СЛИЗИСТАЯ оболочка желудка гладкая, блестящая, диффузно умеренно гиперемирована. В режиме NBI структура желез соответствует отделам желудка, собирательные венулы в виде «морской звезды» прослеживаются сегментарно

ПРИВРАТНИК округлой формы, СМЫКАЕТСЯ, проходим свободно.

ЛУКОВИЦА 12-п. кишки обычной формы и объема, не деформирована. Слизистая луковицы гиперемирована с точечными эрозиями, покрытыми фибрином. ПОСТБУЛЬБАРНЫЕ отделы 12 п.к. свободно проходимы, просвет кишки не расширен, не деформирован, стенки эластичные, перистальтика активная, СКЛАДКИ нормальные по высоте, циркулярные, слизистая оболочка бледно-розовая, ворсинки умеренно выражены. Профильное изображение БДС без особенности. В режиме NBI патологии не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

эрозивный бульбит.

Умеренно выраженный поверхностный гастрит.

Недостаточность кардии 2ст. по NILL

Экспресс-тест на HP(++).

Рекомендовано УЗИ брюшной полости и консультация гастроэнтеролога.

Заключение эндоскопии не является диагнозом и должно быть интерпретировано лечащим врачом с учетом анамнеза заболевания, клинической картины, данных лабораторных и других методов исследования.

Подпись врача: Байборodin Александр Борисович

Дата: 06.12.2025





СМ-Клиника
многопрофильный медицинский холдинг



Общество с ограниченной

ООО "СМ-Медика"

Адрес: 117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 65, корпус 1

Телефон: +7 (495) 777-48-49

Факс

E-mail

Лицензия № ЛО41-01137-77/00351219

Амбулаторная карта № АМ6217403

Прием врача

Дата приема: 06.12.2025 Время: 19:24

ФИО пациента: Микова Чиана Сергеевна

Дата рождения: 24.01.1977 Возраст на момент осмотра: 48 ИДС получено.

Врач: Джантотаев Руслан Борисович

Описание

- гастроскопия,

Время начала анестезии: 19.15

Время окончания анестезии: 19.20

Время окончания postanестетического наблюдения: 19:50

Краткий осмотр анестезиолога:

Сопутствующая патология : Хронический гастрит, панкреатит

Предшествующие анестезии: без особенностей и осложнений. Персональный и семейный анамнез в отношении осложнений, связанных с проведением анестезиологического пособия, отрицательный.

Аллергические реакции: отрицает

Текущая медикаментозная терапия:

Алкоголь: отрицает.

Курение: отрицает.

Токсико- и наркомании: отрицает.

Краткий физикальный осмотр: без особенностей.

Дыхательные пути: шатающихся зубов, съемных зубных протезов нет. Маллампаги 1.

Последний прием пищи: 12 часов назад

Последний прием жидкости: 12 часов назад

Физический статус ASA 2;

Риск анестезии: низкий.

Планируемый вид анестезии: глубокая внутривенная мониторируемая седация на основе пропофола. Стандартный мониторинг ASA.

С особенностями указанного вида анестезиологического пособия, возможными рисками и осложнениями пациент(ка) ознакомлен(а), информированное согласие на проведение анестезиологического пособия получено.

С особенностями режима, питания и приема жидкостей в первые сутки после проведения седации пациент(ка) ознакомлен(а), информация уяснена.

На все заданные пациентом вопросы даны исчерпывающие ответы.

С целью проведения инфузионной терапии, внутривенного введения лекарственных препаратов, больному необходима катетеризация периферической вены.

В горизонтальном положении больного после двукратной асептической обработки места венепункции в области предплечья выполнена пункция и катетеризация v. cefalica sinistra однопросветным периферическим венозным катетером (ПВК) на игле диаметром 22 G. получен свободный ток венозной крови. При контрольном введении изотонических растворов признаков раздражения местных тканей нет. ПВК фиксирован к коже асептической наклейкой.

После осмотра пациента(ки) и получения информированного согласия на проведение анестезиологического пособия пациент(ка) взят(а) на стол для проведения исследования / манипуляции.

Мониторинг: NIBP, HR, SpO2.

АД 120/80 мм.рт.ст, ЧСС 85 мин, ЧД 16 мин, SpO2 99%.

Внутривенный доступ: левая локтевая вена, катетер Vasofix Certo 22G (B.Braun).

Внутривенная седация: Пропрофол-Липуро 10 мг/мл (B.Braun) в/в дробно (по уровню седации) в суммарной дозе 150 мг, Дексаметазон 4 мг в/в,

Течение анестезии гладкое, без особенностей.

Гемодинамика устойчивая,

АД на уровне 110/75 мм рт.ст., ЧСС на уровне 80 мин, пульс ритмичный, удовлетворительных качеств

Дыхание: самостоятельное, адекватное, свободное, дополнительных мер по поддержанию проходимости дыхательных путей и/или ВИВЛ не требовалось.

ЧД на уровне 16/мин, SpO2 95-98%.

По окончании манипуляции введение анестетика прекращено, наступило гладкое пробуждение пациента(ки) в течение 5 минут, без возбуждения

Полное восстановление сознания, ориентации, мышечного тонуса, гемодинамики и вестибулярных реакций: в течение последующих 5 минут.

Через дополнительные 20 минут наблюдения сознания ясное, ориентация полная, мышечный тонус и дыхание адекватные, вестибулярные реакции в норме, Тошноты, рвоты нет.

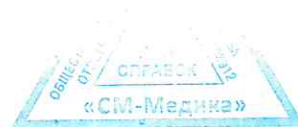
АД 125/70 мм рт.ст., ЧСС 77 мин, ЧД 18 мин, SpO2 99%.

Внутривенный катетер удален, наложена асептическая повязка.

Пациентка отпущена домой, выданы устные рекомендации по режиму и диете в первые сутки после проведения внутривенной седации.

Подпись врача: Джантотаев Руслан Борисович

Дата: 06.12.2025





СМ-Клиника
многопрофильный медицинский холдинг



Общество с ограниченной
ответственностью
ООО "СМ-Медика"
Адрес: 117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 65, корпус 1
Телефон: +7 (495) 777-48-49
Факс: +7 (495) 777-48-49
E-mail: novocheremushkinskaya@sm-medika.ru
Лицензия № ЛО-41-01137-77/00351219

Амбулаторная карта № АМ6217403

ЭЭГ

Дата приема: 01.12.2025 Время: 17:20
ФИО пациента: Микова Чиана Сергеевна
Дата рождения: 24.01.1977 Возраст на момент осмотра: 48 ИДС получено.
Врач: Левченко Юлия Егоровна

Описание

Пациент(ка) обратился(ась) для ЭЭГ самостоятельно, без направления врача.
Пациенту(ке) в доступной форме разъяснено об информативности и диагностических возможностях исследования при отсутствии направления врача на данное исследование. Исследование проведено с согласия пациента(ки) после разъяснительной беседы и подписания ИДС.

В анамнезе приступ с потерей сознания на 5 часов в связи с интоксикацией (отравление) год назад. С тех пор беспокоит слабость.

Лекарственные препараты не принимает.

Травмы головы отрицает.

Протокол обследования

Информация о пациенте:

ФИО: Микова Чиана Сергеевна

Дата рождения: 24.01.1977

Пол: Женский

Возраст: 48 лет

Параметры регистрации:

Название прибора: Нейрон-Спектр-2

Частота квантования: 500 Гц

Название монтажа: Монополярный 16

Фильтр верхних частот: 0,5 Гц

Фильтр нижних частот: 70,0 Гц

Сетевой фильтр: Вкл.

Длительность записи: 00:20:25

Дата обследования: 1 декабря 2025 г.

ЭЭГ проводилось в состоянии активного и пассивного бодрствования с проведением функциональных проб.

Общая характеристика ЭЭГ в покое:

Фоновая запись:

Над обоими полушариями регистрируется альфа-ритм частотой 8-14 Гц. Максимальная амплитуда альфа-ритма над левым полушарием 55 мкВ (средняя 13 мкВ). Максимальная амплитуда альфа-ритма над правым полушарием 50 мкВ (средняя 13 мкВ). Межполушарная асимметрия альфа-ритма отсутствует. Доминирующая частота альфа-ритма 9,7 Гц. Индекс альфа-ритма по спектру 5,8%. Представленность альфа-ритма 69,2%. Альфа-ритм преобладает в F3-A1, F4-A2, C4-A2, P3-A1, P4-A2. Модулированность альфа-ритма умеренная.

Регистрируется низкочастотный бета-ритм частотой 14-20 Гц. Максимальная амплитуда низкочастотного бета-ритма 42 мкВ (средняя 8 мкВ). Индекс бета-НЧ-ритма над левым полушарием (по спектру) 4,8%. Индекс бета-НЧ-ритма над правым полушарием (по спектру) 2,3%. Низкочастотный бета-ритм преобладает в C3-A1, C4-A2, P3-A1, P4-A2.

Регистрируется высокочастотный бета-ритм частотой 20-35 Гц. Максимальная амплитуда высокочастотного бета-ритма 53 мкВ (средняя 7 мкВ). Индекс бета-ВЧ-ритма над левым полушарием (по спектру) 3,9%. Индекс бета-ВЧ-ритма над правым полушарием (по спектру) 2,0%. Высокочастотный бета-ритм преобладает в FP1-A1, FP2-A2, C4-A2, P3-A1, P4-A2.

Присутствует дельта-ритм частотой 1-4 Гц. Максимальная амплитуда дельта-ритма 167 мкВ (средняя 25 мкВ). Доминирующая частота дельта-ритма 0,5 Гц. Дельта-ритм преобладает в FP2-A2.

Присутствует тета-ритм частотой 4-8 Гц. Максимальная амплитуда тета-ритма 74 мкВ (средняя 7 мкВ). Доминирующая частота тета-ритма 4,0 Гц. Индекс тета-ритма по спектру 7,7%. Тета-ритм преобладает в FP1-A1, FP2-A2, F4-A2, C3-A1, C4-A2.

Присутствует тета-ритм частотой 4-8 Гц. Максимальная амплитуда тета-ритма 74 мкВ (средняя 7 мкВ). Доминирующая частота тета-ритма 4,0 Гц. Индекс тета-ритма по спектру 7,7%. Тета-ритм преобладает в FP1-A1, FP2-A2, F4-A2, C3-A1, C4-A2.

Функциональные пробы:

При открывании и закрывании глаз патологические формы активности не зарегистрированы. Реакция активации четкая.

Ритмическая фотостимуляция проводилась частотами 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,60,50,40,30,25 Гц

Фотопароксизмальные формы активности не зарегистрированы.

Максимально усваивается ритм частотой 1 Гц.

Гипервентиляция (в течение 3 минут) — без патологических форм активности.

Заключение:

За время исследования отчетливого регионального замедления, эпилептиформной активности, эпилептических приступов и их субклинических ЭЭГ паттернов не зарегистрировано.

Регистрируются изменения в виде дезорганизации биоэлектрической активности головного мозга за счет низкой представленности альфа-ритма, его нерегулярности, плохой модулированности, отсутствием зональных различий.

Данное заключение не является диагнозом, трактуется лечащим врачом в контексте клинических данных.

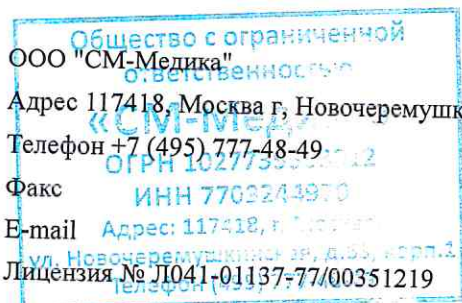
Обследование выполнил врач: Левченко Ю.Е.

тел. +7(495)292-39-72

Подпись врача: Левченко Юлия Егоровна

Дата: 01.12.2025





Эхокардиография (УЗИ сердца)

Дата приема: 04.12.2025 Время: 21:32
 ФИО пациента: Микова Чиана Сергеевна
 Дата рождения: 24.01.1977 Возраст на момент осмотра: 48 ИДС получено.
 Врач: Гусейнова Севиндж Расимовна

Исследование проводилось на аппарате Sonoscape S40 exp секторным датчиком S1-5
Рост 175 см Вес 67 кг
Аорта: не уплотнена, корень 3,0, восходящая 3,4 (N=2,0-3,7 см)
Левое предсердие ПЗР 2,5 см, объем 29,7 мл, ИОЛП 20,4 мл/м2 (N <3,7см, <52мл, <34мл/м2)
Полость левого желудочка: КДР 4,8 (N=3,8-5,2 см), КСР 3,0 (N=2,2-3,5 см)
Сократительная функция левого желудочка: удовлетворительная, ФВ (Simpson) 67 % (N>=54%)
КДО 85 мл, КСО 34 мл. Нарушение локальной сократимости: нет
Межжелудочковая перегородка 1,0 Задняя стенка ЛЖ 0,9 (N=0,6-1,0 см)
ММЛЖ 159 г, ИММЛЖ 88 г/м2, ОТС 0,34
Аортальный клапан: вероятно, 3 створки, видны четко, не уплотнены; Амплитуда раскрытия N
Митральный клапан: створки не уплотнены; Противофаза есть
Правое предсердие: 15,3 (N<18см2)
Правый желудочек: 2,6 (ПЗР, N<3,0 см)
Толщина передней стенки ПЖ: 0,3 (N<0,5см) TAPSE 2,3 см (N>1,7см)
Систолическое давление в легочной артерии: 10+5=15 (≤35 мм рт.ст.)
Легочная артерия 2,1 (≤2,6 см)
Признаки недостаточности клапана: митрального 0 аортального 0
трикуспидального легочного 0

Реакция нижней полой вены на фазы дыхания: более 50%, НПВ не расширена 1,6 см
Диастолическая функция ЛЖ не нарушена E 73 см/с, E/A 1,2, E/e'ср 7,5, e'ср 9,8 см/с
Расхождение листков перикарда: не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Нормальная геометрия левого желудочка. Полости сердца не расширены. Сократительная способность левого желудочка удовлетворительная. Диастолическая функция левого желудочка не нарушена. Признаков легочной гипертензии не выявлено. Данное заключение не является диагнозом, оценивается лечащим врачом с учетом клинических и лабораторных данных. Рекомендована консультация кардиолога.

Подпись врача: Гусейнова Севиндж Расимовна

Дата: 04.12.2025



